



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : دينا كمال السيد علي
المحافظة : الدقهلية
الحى / المدينة : ميت غمر
رقم البطاقة : 28809011214729 رقم التليفون : 01142956469
العمر (تاريخ الميلاد) : 01-09-1988 المهنة : ربه منزل
العنوان : ميت غمر
تاريخ تسجيل الإستمارة : 28-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني + زولاديكس قسم العلاج :
[14165]
الأورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: دينا كمال السيد علي National ID: 28809011214729	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Plus Goserline
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



فيينا
كمال السيد علي حسين
٢٦ ش عبدالله بن الزبير
الخصوص - القليوبية



KY3357312

٢٨٨.٩.١١٢١٤٧٢٩

٢٨٨.٩.١١٢١٤٧٢٩

التي
وليد غاروق مصطفى السيد خلف
البطاقة مصرية حتى ٢٠٢٢/١١/١٢



(٧٠٧ د كس)

سوار

Patient Name : دینا کمال السید
Patient Info. : Female 37Y
Department : Out Patient
Profile NO. : 1135-2024

Patient Id : 2764
VisitId : 143109
Collection Date : 19/01/2026 14:40:30
Reporting Date : 19/01/2026 15:00:21

Clinical Chemistry Report

Test	Result	Unit	Reference Range
<u>Kidney Function</u>			
Calcium Ionized (Ca++)	: 1.20	mmol/L	N. 1.1 - 1.4

Signature
Dr. Sahar Mansour

Name: دينا كمال السيد على		
MR. : 5507		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحتية طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه PREM LEFT BREAST CANCER LT BCS 10/5/2024 T2 N1/11 ER8/8 PR6/8 HER2-VE KI 20 % REC 4 AC TAXOTERE PORT ST ZOLDEX ARIMIDEX FROM25/11/2025. FOR ZOMETA ARIMIDEX ZOLADEX GIVEN 19/1/2026 ZOLADEX +ARAMIDEX+SUPPORTIVE*3M NEXT VISIT :1/10/1026 cts on 27/7/2026 rt lower lobe pulmonary nodule 10 mm likely met evolving (but this nodule is evident in cts 4/2024 m 8x7 mm) for radiological consultation about nature of this nodule and close fu bs 8/2026 free for zometa		
تحريراً في ,		
	التاريخ :	21-09-2026
	الوقت :	dina makram
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		



Prof.
Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	: الأستاذة / د. ال سيد علي حسنين	Request No.	: 13007189
Patient No.	: 28809011214729	Request Date	: 11/05/2024
Path No.	: 1531/24	Verification Date	: 19/05/2024
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 35 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

Diagnosis:

Left breast cancer, Up-front, Left breast conservative surgery and Axillary lymph nodes dissection;

- Invasive duct carcinoma, Grade II, With focal DCIS.
- Resection Margins: Free.
- Lymph nodes: Positive metastatic deposits in one out of eleven lymph nodes, L.N (1/11).
- Stage: pT2, pN1a.

Signature

Dr. Gamal Abd-El-Atty.

Dr. Sagda El-Kady.

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 20/05/2024 10:07:49

Page 2 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt



Total D^a P (mGy.cm):

Patient Name: Dina Kamal Al Sayed Ali Hasanain	Date : 15/04/2024
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 35 Year(s)
Medical ID: 1105/2024	Pat. ID: 49056

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

Reported case of left breast cancer.

I Chest:

- Left breast parenchymal distorsion.
- Enlarged few left axillary (level I) lymph nodes, largest measures about 1.4 cm in short axis.
- Right lower lung anterior segment shows solitary pulmonary nodule measuring about 8x7 mm.
- Otherwise, no sizable pulmonary nodules, masses, areas of ground glass attenuation, consolidation or cavity lesions.
- No CT evidence of pathological mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection, pleural thickening or masses.
- No cardiac gross abnormalities.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is mildly enlarged showing homogenous parenchymal attenuation. No definite focal lesions on non-contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal non contrast CT appearance of the spleen, pancreas, kidneys and suprarenals glands.
- Averagely filled urinary bladder showing no sizable diverticular outpouching.
- No pathological abdominal or pelvic lymph node enlargement.
- No ascites.

III The Examined Skeleton:

- No definite worrisome lytic or sclerotic osseous lesions.

Opinion:

Total DLP (mCi, cm):

Patient Name: Dina Kamal Al Sayed / Hasanain	Date : 15/04/2024
Exam : C.T ABDOMEN & PELVIS	Age : 35 Year(s)
Medical ID: 1135/2024	Pat. ID: 10058

- Left breast parenchymal distorsion with enlarged few left axillary lymph nodes. For sonomammography correlation.
- Right lower lung solitary pulmonary indeterminate nodule, for follow up.
- No definite hepatic or osseous deposits.

Dr. Ali Elsisy, MSc
Dr. Reham Anwar, FEBR, MD



Patient Name: Dina Kamal Al Sayed Ali Hasanain	Date : 25/11/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 36 Year(s)
Medical ID: 1135/2024	Pat. ID: 49056

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH
RESOLUTION ULTRASOUND**

Indication:

Left breast conserving therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)

Left breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable mass with operative bed areas of fat necrosis and echogenic fat planes.
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- No sizable collection
- Diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Right Breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post left BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal study of the right breast (BIRADS 1)

Dr. mohamed Mohsen, M.D.



mod

Patient Name	: الأستاذة / دينا كمال السيد على حسين	Request No.	: 13007189
Patient No.	: 28809011214729	Request Date	: 11/05/2024
Path No.	: 1531/24	Verification Date	: 19/05/2024
Sex	: Female	Financial Category	: أورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 35 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc	:	Registered by	: marwa mohamed vnuiss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Up-Front.

Nature Specimen: Left breast conservative surgery and Axillary lymph nodes dissection.

Gross Examination:

- Left BCS specimen measured 13x9x5 cm, with no covering skin.
- Tumor extent: A firm grayish white mass.
- Size: 4.7x3.5x3 cm.
- Distance from margins: 0.2 cm away from the least superficial margin.
- Left ALND: A fibrofatty tissue piece measured 7x6x3 cm, entangling 11 nodules, up to 4x3x1 cm.
- 11 Blocks:
- 1- medial margin, 2- Lateral margin, 3- Superior margin, 4- Inferior margin, 5- Superficial margin, 6- Deep margin, 7:10- Mass, 11:12- Lymph nodes.
- Gross was done by; Dr. Moha... Turkey.
- Frozen Results:
- Free surgical margins.

Microscopic Examination:

- Left breast, Left breast conservative surgery and Axillary lymph nodes dissection:
- Histological Type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+2) Grade II.
- Ductal carcinoma in situ: Focally detected.
- Angioinvasion: Present.
- Perineural invasion: Not detected.
- Resection Margins: Free.
- Lymph nodes: Positive metastatic deposits in one out of eleven lymph nodes, L.N (1/11).

Verified by :

Dr.Duaa Mohamed

Printing Date : 20/05/2024 10:07:49

Page 1 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy





مركز النور المحمدي للأشعة

Alnour Almohammady Radiological Center

رنين مغناطيسي مفتوح - أشعة مقطعية - موجات صوتية - دوبرلر ملون

مسجد النور المحمدي - ميدان الساعة

Alnour Almohammady Mosque - Mesalla Square

Tel: 26509782 - 22517341 - 225502599

Dear Prof. Dr :

Date : 16 March 2024

Patient's name: دنيا كمال

BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND BREAST U/S

- ACR b breast parenchymal density
- No gross speculated masses or pathological calcifications on right side
- US revealed mildly mottled echoing parenchyma with no solid lesions seen by US on RT side
- Left breast upper central irregular high density lesion seen by US as irregular heterogeneous hypoechoic solid lesion located at 1 o'clock at site of pt complaint measuring about 37x28 mm with associated ductal extension and smaller lesion along ductal extension measuring about 15x6 mm
- Right sided likely non specific axillary LNS .
- Left sided pathological level 1 lymph nodes are seen
- No pathological supraclavicular LNS

CONCLUSION :-

- **BIRADS IV LT** breast highly suspicious lesions with pathological axillary lymph nodes as described for further work up

Yours truly

Dr./ OMNIA MOKHTAR ,MD

LTBCS

✓